

Hypertension artérielle

L'essentiel

- On estime que 1,4 milliard d'adultes âgés de 30 à 79 ans dans le monde souffraient d'hypertension en 2024 ; soit 33 % de la population de cette tranche d'âge
 - Les deux tiers des adultes âgés de 30 à 79 ans qui souffrent d'hypertension vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire.
 - On estime que 600 millions d'adultes atteints d'hypertension (44 %) l'ignorent.
 - Environ 630 millions d'adultes atteints d'hypertension (4 %) sont diagnostiqués et traités.
 - L'hypertension est maîtrisée chez environ 320 millions d'adultes (23 %).
 - L'hypertension est l'une des premières causes de décès prématuré dans le monde.
 - L'une des cibles mondiales en matière de lutte contre les maladies non transmissibles consiste à réduire la prévalence de l'hypertension non maîtrisée de 25 % entre 2010 et 2025.
-

Généralités

L'hypertension (pression artérielle élevée) correspond à une pression trop élevée dans les vaisseaux sanguins (140/90 mmHg ou plus). Elle est fréquente, mais peut être grave si elle n'est pas traitée.

Les personnes souffrant d'hypertension artérielle peuvent ne pas ressentir de symptômes. La seule façon de le savoir est de faire vérifier sa tension artérielle.

Parmi les facteurs qui augmentent le risque d'avoir une pression artérielle élevée figurent :

- un âge avancé
- le bagage génétique
- le surpoids ou l'obésité
- le manque d'activité physique
- une alimentation riche en sel
- une consommation excessive d'alcool.

Les changements de mode de vie comme adopter une alimentation plus saine, cesser de fumer et être plus actif peuvent aider à abaisser la tension artérielle. Certaines personnes peuvent toutefois avoir besoin de prendre des médicaments.

La tension artérielle est indiquée par deux chiffres. Le premier chiffre (qui indique la tension systolique) correspond à la pression dans les artères lorsque le cœur se contracte ou bat. Le deuxième chiffre (qui indique la tension diastolique) correspond à la pression dans les artères au moment du relâchement du cœur. On considère qu'une personne souffre d'hypertension lorsque l'on constate à deux reprises, et pas

le même jour, une tension artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mmHg et/ou une tension artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mmHg.

Facteurs de risque

Les facteurs de risque modifiables sont l'alimentation déséquilibrée (consommation excessive de sel ou de graisses saturées et d'acides gras trans, et consommation insuffisante de fruits et de légumes), la sédentarité, la consommation de tabac et d'alcool, et le surpoids ou l'obésité. Il existe également des facteurs environnementaux de risque d'hypertension, dont le principal est la pollution de l'air, auxquels sont associées des maladies. Les facteurs de risque non modifiables sont les antécédents familiaux d'hypertension, le vieillissement (personnes âgées de plus de 65 ans) et la coexistence d'autres pathologies telles que le diabète ou une maladie rénale.

Symptômes

La plupart des personnes souffrant d'hypertension ne ressentent aucun symptôme. Les pressions artérielles très élevées peuvent toutefois causer des maux de tête, une vision floue, des douleurs thoraciques et d'autres symptômes.

Vérifier votre tension artérielle est la meilleure façon de savoir si vous avez une pression artérielle élevée. Si l'hypertension n'est pas traitée, elle peut entraîner d'autres problèmes de santé comme les maladies rénales, les cardiopathies et les accidents vasculaires cérébraux.

Les personnes ayant une pression artérielle très élevée (habituellement 180/120 ou plus) peuvent notamment éprouver les symptômes suivants :

- maux de tête intenses
- douleurs thoraciques
- vertiges
- difficulté à respirer
- nausées
- vomissements
- vision floue ou autres altérations de la vision
- anxiété
- état confusionnel
- bourdonnement dans les oreilles
- saignements de nez
- anomalie du rythme cardiaque.

Si vous éprouvez l'un de ces symptômes et que votre pression artérielle est élevée, consultez immédiatement un professionnel de santé.

Pour dépister l'hypertension, le seul moyen est de faire mesurer sa tension artérielle par un professionnel de santé. Ce processus est rapide et indolore. Bien qu'il soit également possible de mesurer sa tension artérielle à l'aide d'un appareil

automatique, le risque et les pathologies associées doivent absolument être évalués par un professionnel de santé.

Traitement

Changer de mode de vie peut aider à réduire l'hypertension artérielle. Il convient notamment :

- d'avoir une alimentation saine à faible teneur en sel
- de perdre du poids
- d'être actif physiquement
- d'arrêter de fumer.

Si vous souffrez d'hypertension artérielle, votre médecin peut vous prescrire un ou plusieurs médicaments. La pression artérielle qu'il vous est recommandé d'atteindre peut dépendre des autres problèmes de santé que vous avez.

Elle doit être inférieure à 130/80 si vous avez l'une des pathologies suivantes :

- maladie cardiovasculaire (cardiopathie ou accident vasculaire cérébral)
- diabète (glycémie élevée)
- maladie rénale chronique
- risque élevé de maladie cardiovasculaire.

Pour la plupart des personnes, l'objectif est d'avoir une pression artérielle inférieure à 140/90.

Il existe plusieurs médicaments courants pour lutter contre l'hypertension artérielle :

- les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA) entraînent un relâchement des vaisseaux sanguins et permettent de prévenir les lésions rénales (énalapril et lisinopril, par exemple) ;
- les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine-2 (ARA) entraînent un relâchement des vaisseaux sanguins et permettent de prévenir les lésions rénales (losartan et telmisartan, par exemple) ;
- les inhibiteurs calciques entraînent un relâchement des vaisseaux sanguins (amlodipine et félodipine, par exemple) ;
- Les diurétiques éliminent l'eau excédentaire dans l'organisme abaissant ainsi la pression artérielle (hydrochlorothiazide et chlorthalidone, par exemple).

Prévention

Les changements de mode de vie peuvent permettre de réduire l'hypertension artérielle et aider toute personne souffrant d'hypertension. Beaucoup de ceux qui font ces changements devront toutefois prendre des médicaments.

Ces changements de mode de vie peuvent aider à prévenir et à réduire l'hypertension artérielle.

Ce qu'il faut faire :

- manger plus de légumes et de fruits ;
- rester assis moins longtemps ;
- être plus actif physiquement, en pratiquant des activités telles que la marche, la course, la natation, la danse ou des activités de renforcement musculaire, comme soulever des poids ;
 - pratiquer au moins 150 minutes par semaine d'activité aérobique d'intensité modérée ou 75 minutes par semaine d'activité aérobique d'intensité soutenue ;
 - faire des exercices de renforcement musculaire 2 jours ou plus chaque semaine ;
- perdre du poids si vous êtes en surpoids ou obèse ;
- prendre les médicaments prescrits par votre professionnel de santé ;
- consulter régulièrement votre professionnel de santé ;

Ce qu'il ne faut pas faire :

- manger trop d'aliments salés (essayez de rester en dessous de 2 grammes par jour) ;
- manger des aliments riches en acides gras saturés ou trans ;
- fumer ou consommer du tabac ;
- avoir une consommation excessive d'alcool (1 verre par jour maximum pour les femmes, 2 pour les hommes) ;
- ne pas prendre ses médicaments ou les partager.

La réduction de l'hypertension permet de prévenir les infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux, les lésions rénales, ainsi que d'autres problèmes de santé.

Pour réduire les risques associés à l'hypertension, il convient de :

- réduire et gérer son stress
- faire régulièrement contrôler sa tension artérielle
- soigner son hypertension
- prendre en charge ses autres problèmes de santé
- réduire l'exposition à l'air pollué.

Complications d'une hypertension non maîtrisée

L'hypertension peut entraîner de nombreuses complications et notamment de graves lésions cardiaques. Une pression excessive peut durcir les artères, diminuer le flux sanguin et le flux d'oxygène vers le cœur. Cette pression élevée et la réduction du flux sanguin peuvent causer :

- des douleurs thoraciques (angine de poitrine ou angor) ;
- un infarctus du myocarde, qui se produit lorsque la circulation sanguine vers le cœur est interrompue et que les cellules du muscle cardiaque se nécrosent par manque d'oxygène ; plus l'interruption est longue, plus les lésions cardiaques seront importantes ;
- une insuffisance cardiaque, qui survient lorsque le cœur n'est plus en mesure de pomper suffisamment de sang et d'oxygène à destination des autres organes vitaux ; et
- un trouble du rythme cardiaque, qui peut conduire à une mort subite.

L'hypertension peut également provoquer l'éclatement ou l'obstruction d'une artère qui irrigue le cerveau et l'alimente en oxygène, et entraîner un accident vasculaire cérébral.

De plus, l'hypertension peut entraîner des lésions puis une insuffisance rénales.

Prévalence de l'hypertension

La prévalence de l'hypertension varie selon les régions et les groupes de revenu des pays. La Région OMS de la Méditerranée orientale a la prévalence la plus élevée de l'hypertension (38 %), tandis que la Région du Pacifique occidental de l'OMS a la plus faible (29 %).

Le nombre d'adultes souffrant d'hypertension a augmenté, passant de 650 millions en 1990 à 1,4 milliard en 2024, et c'est surtout dans les pays à revenu faible ou intermédiaire que cette hausse a été observée. Cette augmentation est principalement attribuable à une augmentation du nombre de personnes âgées dans ces pays.

Action de l'OMS

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) aide les pays à réduire la prévalence de l'hypertension en tant que problème de santé publique.

En 2021, l'OMS a publié de nouvelles lignes directrices pour le traitement pharmacologique de l'hypertension chez l'adulte. Cette publication fournit des recommandations reposant sur des données factuelles sur la mise en place d'un traitement de l'hypertension, et les intervalles de suivi recommandés. Le document indique aussi la tension artérielle à atteindre pour maîtriser l'hypertension, et comporte des informations sur le personnel qui, dans le système de santé, peut mettre en place le traitement.

Pour aider les gouvernements à renforcer la lutte contre les maladies cardiovasculaires, l'OMS et les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis d'Amérique (CDC) ont lancé en septembre 2016 la Global Hearts Initiative, qui comprend le guide technique HEARTS. Les six modules du guide technique HEARTS (conseils pour un mode de vie sain, protocoles de traitement élaborés sur des bases factuelles, accès aux médicaments et aux technologies essentiels, prise en charge fondée sur les risques, soins dispensés en équipe et systèmes de suivi) constituent une approche stratégique pour améliorer la santé cardiovasculaire dans le monde.

Depuis septembre 2017, l'OMS est en partenariat avec Resolve to Save Lives, une initiative de Vital Strategies visant à aider les gouvernements nationaux à mettre en œuvre l'initiative Global Hearts. Les autres partenaires qui contribuent à l'Initiative Global Hearts sont les suivants : la CDC Foundation, le Global Health Advocacy Incubator, la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) et les CDC des États-Unis d'Amérique. Depuis la mise en œuvre du programme dans 40 pays à revenu faible ou intermédiaire en

2017, environ 13,5 millions de personnes ont été traitées pour une hypertension sur la base d'un protocole suivant des modèles de soins centrés sur la personne. Ces programmes montrent que les programmes standardisés de lutte contre l'hypertension peuvent être mis en œuvre et sont efficaces.

Actualités

L'hypertension artérielle non maîtrisée expose plus d'un milliard de personnes à des risques de maladies 23 septembre 2025

Principaux repères

Maladies cardiovasculaires 31 juillet 2025

Maladies non transmissibles 25 septembre 2025

Prééclampsie 10 décembre 2025